Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002112-60.2025.8.21.6001/RS

AUTOR: JULIANA MORAIS PINDARE

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

JULIANA MORAIS PINDARE ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **Neoplasia maligna de mama (CID10-C50.9)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Abemaciclibe 150 mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça (evento 17, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 23, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 25, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 32, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 34, DESPADEC1), o demandado nada requereu (evento 40, PET1) e a parte autora produziu prova documental (evento 41, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 44, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 17, DESPADEC1):

> *Segundo o laudo médico acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de **Neoplasia maligna de mama (CID10 - C50.9),** necessitando fazer uso do medicamento **Abemaciclibe 150 mg.** Ressaltou a **urgência** do tratamento, visto que a não utilização do fármaco poderá trazer progressão rápida de doença e óbito. (evento 1, LAUDO14):*
>
> *[...]*
>
> *A nota técnica, por sua vez, sobreveio com **conclusão favorável** ao tratamento requerido (evento 12, NOTATEC1):*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito uma negativa administrativa (evento 1, INDEFERIMENTO11).*
>
> *Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*
>
> *Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.*
>
> *Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar n.º 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPE-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Abemaciclibe 150 mg**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, LAUDO14), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **Neoplasia maligna de mama (CID10-C50.9)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Abemaciclibe 150 mg**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, salientando o laudo médico que o uso mais breve possível da medicação evitará a progressão rápida da doença e o risco de óbito. Senão vejamos:

Porto Alegre, 07 de novembro de 2024.

Nome: Juliana Morais Pindare

Paciente de 44 anos, pré-menopausa, com diagnóstico de neoplasia maligna de CID-10 C50.9, receptores hormonais positivos, doença localmente avançada ao diagnóstico com comprometimento de linfonodos axilares. Submetida à quimioterapia neoadjuvante baseada em antraciclina e taxano, seguida de cirurgia com achado de doença residual na mama e na axila, tumor medindo 5,2 cm e 6 linfonodos comprometidos.

Diante do achado de doença residual na axila (6 linfonodos), recebe recomendação de Abemaciclibe 150 mg 12/12 horas contínuo por 2 anos, associado à terapia endócrina, conforme dados do estudo MonarchE (Rastogi et al., 2024). Este trial randomizou mulheres com diagnóstico de câncer de mama receptor hormonal positivo com 4 ou mais linfonodos axilares positivos ou 1-3 linfonodos e pelo menos 1 característica de alto risco - tamanho do tumor de 5 cm ou maior, grau 3, Ki-67 de 20% ou mais - para receber terapia endócrina isolada ou combinada a Abemaciclibe. Houve ganho estatisticamente significativo em sobrevida livre de doença invasiva com Abemaciclibe (83,6% com Abemaciclibe vs 76% com terapia endócrina isolada aos 5 anos, HR 0,68, p<0,001) e em sobrevida livre de recorrência à distância (86% com Abemaciclibe vs 79,2% com terapia endócrina isolada, HR 0,675, p<0,001).

Além disso, guidelines da Sociedade Europeia de Oncologia (ESMO) e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) endossam o uso de Abemaciclibe neste cenário diante do benefício obtido.

Consta em bula que o Abemaciclibe é indicado em combinação com terapia endócrina para o tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama precoce, com alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR+), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2-) e linfonodo positivo.

Esta medicação já está aprovada pela Anvisa.

A não liberação do tratamento de maneira urgente poderá implicar em progressão rápida de doença e óbito.

gov.br Documento assinado digitalmente
MAIANE MARIA PAULETTO
Data: 07/11/2024 13:16:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ainda, o **laudo médico atualizado** indica que a paciente apresentou boa tolerância ao uso da medicação pleiteada, sem evidência de recidiva, sendo necessária a manutenção do tratamento por tempo indeterminado (evento 41, LAUDO3):

Porto Alegre, 04 de junho de 2025.

Nome: Juliana Morais Pindare

Paciente de 44 anos, pré-menopausa, com diagnóstico de neoplasia maligna de CID-10 C50.9, receptores hormonais positivos, doença localmente avançada ao diagnóstico com comprometimento de linfonodos axilares. Submetida à quimioterapia neoadjuvante baseada em antraciclina e taxano, seguida de cirurgia com achado de doença residual na mama e na axila, tumor medindo 5,2 cm e 6 linfonodos comprometidos.

Diante do achado de doença residual na axila (6 linfonodos), recebeu recomendação de Abemaciclibe 150 mg 12/12 horas contínuo por 2 anos, associado à terapia endócrina, conforme dados do estudo MonarchE (Rastogi et al., 2024). Está atualmente em uso deste tratamento, com boa tolerância, sem evidência de recidiva.

Mantém acompanhamento e tratamento oncológico regular.

DRA. MAIANE M. BASLETTO
CRM/RS 34304

Com efeito, a médica assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pela médica assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por JULIANA MORAIS PINDARE em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Abemaciclibe,** na dosagem e periodicidade determinadas pela médica assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** à procuradora da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 23/06/2025, às 16:03:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10085050214v5** e o código CRC **f20feef3**.